DOCTRINE ÉCONOLOGIQUE · PILIER V

# 🎯 ALLER DROIT AU BUT

## « Prévenir coûte moins cher que réparer. »

*Le grand âge n'est pas une charge passive : c'est un test de civilisation et d'organisation.*

**[FAIT]** 2,0 millions de seniors étaient en perte d'autonomie en 2021 ; ils seraient 2,8 millions en 2050 (DREES, février 2026).

### DEUX BILLETS POUR VOIR LE MUR QUI ARRIVE

SCÉNARIO 1 · PRIORITÉ AU DOMICILE

**Sans nouvelles places**

| | |
|---|---|
| Emplois en plus en 2050 | + 156 000 |
| dont aides à domicile | + 118 000 |

*DREES, ER n° 1365, hypothèse intermédiaire, en équivalents temps plein.*

SCÉNARIO 2 · PRATIQUES ACTUELLES

**On continue comme avant**

| | |
|---|---|
| Emplois en plus en 2050 | + 202 000 |
| Places d'EHPAD à créer | + 365 000 |

*Pour 640 000 places existantes en 2021 (DREES).*

**+ 0,8 M** — **de seniors en perte d'autonomie en plus d'ici 2050. Chaque année sans réforme rend la marche plus haute, alors que le secteur peine déjà à recruter aujourd'hui.**

**[CALCUL]** 2,8 millions en 2050 − 2,0 millions en 2021 = 0,8 million. Le choix entre domicile et EHPAD change à la fois le nombre d'emplois et le nombre de places à construire.

**ÇA EXISTE DÉJÀ**

**[FAIT]** Depuis 2022, en Allemagne, une maison de retraite n'est financée par l'assurance dépendance que si elle paie ses soignants au niveau des conventions collectives.

Source officielle : https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/rl-tariflohn-langzeitpflege

**LA QUESTION POLITIQUE**

**Qui prendra soin de 800 000 seniors dépendants de plus en 2050, quand les établissements manquent déjà de bras ?**

[FAIT] donnée sourcée · [CALCUL] calcul reproductible · [HYPOTHÈSE] à démontrer · [ANALYSE] lecture de la doctrine · [PROPOSITION] mesure proposée

# Le coût de la non-réforme

[ANALYSE] Le débat public regarde la dépense nouvelle et ignore les coûts déjà subis. La crise du grand âge se paie déjà, mais mal, tard et de façon dispersée :

- intérim coûteux, arrêts maladie et postes vacants ;
- hospitalisations évitables et entrées prématurées en EHPAD ;
- épuisement des familles et des aidants ;
- départ de soignants formés en France vers la Suisse, le Luxembourg ou Monaco.

## Chiffres clés

**156 000 à 202 000**

[FAIT] emplois supplémentaires nécessaires en 2050 selon le scénario (DREES)

**365 000**

[FAIT] places d'EHPAD à créer d'ici 2050 si les pratiques d'admission restent inchangées

**2 à 2,8 Md€/an**

[HYPOTHÈSE] coût brut d'une réforme ciblée des EHPAD, selon le dossier du pilier

**6 à 8 Md€/an**

[HYPOTHÈSE] coût brut d'une réforme large EHPAD et domicile, avant retours fiscaux et sociaux

> CHIFFRES DU DOSSIER À RATTACHER À LEUR SOURCE
>
> [HYPOTHÈSE] 800 000 recrutements cumulés d'ici 2050 ; 12 000 à 15 000 soignants français exerçant à l'étranger ; un taux d'encadrement de 0,6 à 0,7 ETP par résident à porter à 0,8.
>
> Ces ordres de grandeur restent utilisables, mais chacun doit être rattaché à une publication officielle avant diffusion large.

> [ANALYSE] AIDE À MOURIR ET CRISE DU SOIN
>
> **Il ne faut pas dire que l'aide à mourir viserait des économies : ce n'est pas démontré. La critique défendable est ailleurs : la liberté de mourir n'est pleinement libre que si les conditions de vivre dignement sont garanties — soins, maintien à domicile, soins palliatifs, présence humaine.**

ALLER DROIT AU BUT · PILIER V

# La réforme éconologique

## Phase 1 : rendre visible

| | |
|---|---|
| 1 | **LE TAUX D'ENCADREMENT PUBLIÉ**<br>Publier chaque année, établissement par établissement, le personnel réellement présent par résident. |
| 2 | **LE COÛT DE LA PÉNURIE CHIFFRÉ**<br>Publier le coût de l'intérim, des postes vacants et de l'absentéisme, par établissement et par département. |
| 3 | **LES HOSPITALISATIONS ÉVITABLES SUIVIES**<br>Mesurer les passages aux urgences et hospitalisations évitables des personnes âgées, à domicile comme en EHPAD. |

## Phase 2 : investir dans le soin

**1. Des ratios et des salaires.** [PROPOSITION]
Augmenter le personnel par résident vers 0,8 ETP et revaloriser les métiers du soin : sans effectifs, les hausses de salaire seules ne suffisent pas.

**2. Le domicile d'abord.** [PROPOSITION]
Retarder l'entrée en EHPAD quand c'est possible : c'est le scénario qui demande le moins de places à construire.

**3. Faire revenir les soignants partis.** [PROPOSITION]
Une politique ciblée de retour des soignants français partis en Suisse, au Luxembourg ou à Monaco : déjà formés, immédiatement opérationnels.

**4. La robotique gériatrique, enjeu industriel européen.** [PROPOSITION]
Préparer l'assistance robotique au soin, angle mort stratégique de l'Europe face au Japon et aux États-Unis.

FORMULE FINALE

**Une société qui ne prend plus soin de ses anciens finit par payer plus cher sa propre désorganisation.**

POUR ALLER PLUS LOIN

Annexe chiffrée du Pilier V — chaque chiffre avec sa source et la manière juste de le citer

## Sources principales


- DREES — Études et résultats n° 1365, Soutien à l'autonomie des personnes âgées (février 2026)
- Infirmiers.com — Un impératif besoin de personnel d'ici 2050


*Mise à jour du 2 octobre 2026 · Chiffres alignés sur la DREES (février 2026).*

Voir le site Doctrine Éconologique